

Abdome Agudo Inflamatório

Quando falamos em abdome agudo inflamatório, estamos diante de algumas das causas mais frequentes de atendimento cirúrgico de urgência. Vamos começar com um caso clínico que ilustra perfeitamente a apresentação clássica de apendicite aguda: paciente Pedro chega ao pronto-socorro às 8h30 relatando que, no dia anterior à tarde, começou a sentir uma dor vaga na região do umbigo, acompanhada de náuseas. Tomou um antiemético, mas não houve melhora. A dor foi progressivamente aumentando até que ele vomitou. Mesmo após o vômito, a dor persistiu. À noite apresentou febre e inapetência, tomou dipirona e conseguiu dormir. Porém, às 5h da manhã acordou com dor intensa em fossa ilíaca direita, tão forte que mal conseguia se movimentar.

Esse quadro clínico é extremamente característico e nos ajuda a entender a fisiopatologia da doença. Vamos mergulhar agora no estudo sistemático da **apendicite aguda**, que é o abdome agudo cirúrgico mais comum e uma das primeiras cirurgias que todo residente de cirurgia geral precisa dominar.

Apendicite Aguda: Epidemiologia e Conceitos Fundamentais

A **apendicite aguda** representa o abdome agudo cirúrgico mais prevalente na prática clínica, acometendo aproximadamente 8% da população em algum momento da vida. Do ponto de vista epidemiológico, observamos maior incidência na **idade escolar e entre a segunda e terceira décadas de vida**, embora possa ocorrer em qualquer faixa etária, incluindo idosos. Existe um predomínio no sexo masculino, com proporção de aproximadamente 2:1 em relação ao sexo feminino.

Em relação à mortalidade, os números variam significativamente conforme a complexidade do quadro. Nos casos simples, não complicados, a mortalidade é

bastante baixa, variando entre 0,5% e 5%. Entretanto, quando estamos diante de **apendicite complicada** - com perfuração, abscesso ou peritonite difusa - esse índice pode saltar para 15%, especialmente na população idosa e imunocomprometida, que apresenta menor reserva fisiológica e resposta imunológica menos eficaz.

Anatomia e Função do Apêndice Vermiforme

Para compreendermos adequadamente a fisiopatologia da apendicite, precisamos revisar alguns aspectos anatômicos essenciais. O **apêndice cecal** localiza-se na **fossa ilíaca direita**, mais especificamente no terço distal entre o umbigo e a espinha ilíaca ânterossuperior direita. Um detalhe anatômico importante e que frequentemente cai em provas de residência é que sua **irrigação arterial** provém da **artéria apendicular**, que é ramo direto da **artéria ileocólica**.

Vale ressaltar que a posição do apêndice pode variar consideravelmente, o que explica apresentações clínicas atípicas. As principais variações anatômicas incluem posição **pélvica** (mais comum em mulheres), **retrocecal** (a mais frequente das variantes) e até **sub-hepática** quando o apêndice é excepcionalmente longo. Essa variabilidade anatômica tem implicação clínica direta, pois um apêndice retrocecal inflamado pode apresentar dor mais posterior ou em flanco, enquanto um apêndice pélvico pode manifestar-se com sintomas urinários ou retais predominantes.

Do ponto de vista funcional, o apêndice é rico em **tecido linfoide**, particularmente em **imunoglobulina A secretória (IgA)**, desempenhando papel na imunidade intestinal local e auxiliando na manutenção da flora bacteriana intestinal, servindo como reservatório para recolonização após processos infecciosos.

Fisiopatologia: Entendendo a Progressão da Doença

A apendicite aguda evolui através de fases fisiopatológicas bem definidas, e compreender essa progressão é fundamental tanto para o diagnóstico quanto para o manejo adequado. Podemos dividir a evolução em quatro fases principais:

Fase 1 - Edema e Distensão: Nesta fase inicial, ocorre obstrução da luz apendicular, levando ao acúmulo de secreções e consequente distensão do órgão. O paciente tipicamente refere dor vaga, mal localizada, geralmente na região **epigástrica ou periumbilical**. Isso ocorre porque o apêndice, como estrutura embrionariamente derivada do intestino médio, tem sua inervação visceral compartilhada, resultando em dor referida na linha média do abdome.

Fase 2 - Isquemia e Ulceração: Com a progressão da obstrução e distensão, há comprometimento do suprimento sanguíneo da parede apendicular, iniciando um processo isquêmico. Neste momento, a dor torna-se **mais localizada na região da fossa ilíaca direita**, pois o processo inflamatório começa a irritar o peritônio parietal adjacente, que possui inervação somática bem localizada.

Fase 3 - Abscesso e Necrose: Quando não tratada, a isquemia evolui para necrose tecidual. O quadro clínico torna-se mais exuberante, com **febre alta e leucocitose acentuada**. Pode haver formação de abscesso localizado, representando uma tentativa do organismo de conter o processo infeccioso.

Fase 4 - Peritonite Difusa e Perfuração: Esta é a fase mais grave, caracterizada por perfuração da parede apendicular com extravasamento de conteúdo fecal para a cavidade peritoneal. O paciente apresenta **sinais de irritação peritoneal difusa**, com abdome em tábua, rigidez muscular e dor à descompressão em todo o abdome. Este é um quadro de extrema gravidade que requer intervenção cirúrgica urgente.

Causas de Obstrução Apendicular

A obstrução da luz do apêndice é o evento desencadeador primário na maioria dos casos de apendicite aguda. As principais causas incluem: **hiperplasia linfoide** (especialmente comum em crianças e adolescentes, onde o tecido linfoide é mais desenvolvido e pode sofrer hiperplasia reacional a infecções virais); **fecalitos** (pequenos fragmentos de fezes endurecidas que podem impactar na luz estreita do apêndice, sendo particularmente comuns em adultos); **parasitas intestinais** (como oxiúros, principalmente em regiões endêmicas); e mais raramente **tumores** (como

tumores carcinoides ou adenocarcinoma do apêndice, geralmente achados incidentais no exame anatomopatológico).

Quadro Clínico: Sintomas Clássicos e Apresentações Atípicas

A apresentação clínica clássica da apendicite aguda segue um padrão bastante característico que todo médico deve reconhecer. Inicialmente, o paciente refere **dor epigástrica ou periumbilical**, de caráter vago e mal definido. Essa dor tem a particularidade de **migrar para a fossa ilíaca direita** ao longo de horas, tornando-se mais intensa e bem localizada. Este é um dos sinais clínicos mais importantes e específicos de apendicite aguda.

Acompanhando a dor, surgem sintomas gastrointestinais como **anorexia** (perda do apetite), **náuseas** e frequentemente **vômitos**. É importante notar que o vômito na apendicite costuma ser consequência da dor e não sua causa, diferentemente de uma gastroenterite aguda onde o vômito tende a preceder a dor abdominal. O paciente pode apresentar **febre**, geralmente de baixa intensidade no início, mas que tende a se elevar conforme a doença progride. A dor tem característica **progressiva**, iniciando com baixa intensidade e aumentando gradualmente até se tornar incapacitante.

Porém, nem todo paciente apresenta esse quadro típico. Existem **apresentações atípicas** que merecem atenção especial. Em **pacientes idosos**, o quadro clínico costuma ser mais insidioso e menos específico. A dor pode ser difusa, sem localização clara em fossa ilíaca direita, e muitas vezes referida em hipogástrio. Esses pacientes frequentemente não apresentam febre ou leucocitose significativa, o que pode retardar o diagnóstico e aumentar o risco de complicações.

Em **pacientes diabéticos**, devido à neuropatia autonômica e alterações na percepção dolorosa, os sintomas podem ser ainda mais atenuados. A dor abdominal pode ser difusa ou até ausente, mesmo em casos de apendicite

perfurada. Alguns pacientes diabéticos só procuram atendimento quando já desenvolveram complicações como abscesso ou peritonite.

As **gestantes** merecem consideração especial. À medida que o útero gravídico cresce, principalmente a partir do segundo trimestre, ele desloca o ceco superiormente. Com isso, um apêndice inflamado pode causar dor em **flanco direito ou região lombar**, e não em fossa ilíaca direita como esperado. Os sintomas são frequentemente inespecíficos, podendo ser confundidos com contrações uterinas ou outras causas obstétricas de dor abdominal. A apendicite na gestação é particularmente preocupante, pois o atraso no diagnóstico aumenta significativamente o risco de perfuração e morbimortalidade tanto materna quanto fetal.

Semiologia: Sinais Clínicos Fundamentais

O exame físico cuidadoso é absolutamente crucial para o diagnóstico de apendicite aguda. Diversos sinais clínicos foram descritos ao longo dos anos, e embora nem todos sejam utilizados rotineiramente na prática clínica moderna, seu conhecimento é essencial para provas de residência médica.

O **sinal de Blumberg** é sem dúvida o mais importante e cobrado em provas. Ele consiste em **descompressão brusca dolorosa** na fossa ilíaca direita. Realiza-se pressionando profundamente a fossa ilíaca direita e, ao retirar rapidamente a mão, o paciente refere dor intensa no local. Este sinal indica irritação peritoneal e tem alta sensibilidade para apendicite aguda. Uma pegadinha clássica de prova é confundir o sinal de Blumberg com o ponto de McBurney, que é apenas um ponto anatômico de referência.

O **ponto de McBurney** é um marco anatômico localizado no terço distal de uma linha traçada entre a espinha ilíaca ânterossuperior direita e a cicatriz umbilical. A dor à palpação deste ponto sugere apendicite, mas por si só não caracteriza o sinal de Blumberg.

O **sinal de Rovsing** é outro sinal clássico bastante cobrado. Consiste em palpar profundamente a **fossa ilíaca esquerda** e o paciente referir dor na **fossa ilíaca direita** . O mecanismo proposto é que a compressão da fossa ilíaca esquerda desloca gases do cólon descendente e sigmoide para o cólon direito, distendendo o ceco e irritando o apêndice inflamado adjacente.

O **sinal do psoas** é pesquisado com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Solicita-se que ele estenda o membro inferior direito contra resistência. Se há dor na fossa ilíaca direita, o teste é positivo. Este sinal sugere que o apêndice inflamado está em posição **retrocecal** , em contato direto com o músculo psoas, e sua contração irrita o peritônio inflamado.

O **sinal do obturador** é testado com o paciente em decúbito dorsal. Flexiona-se o quadril e joelho direitos a 90 graus e realiza-se rotação interna do quadril. Dor durante esta manobra sugere apêndice em posição **pélvica** , irritando o músculo obturador interno.

O **sinal de Dunphy** é observado quando o paciente **tosse** e refere dor espontânea na fossa ilíaca direita. Este é um sinal de irritação peritoneal estabelecida, sugerindo apendicite complicada.

Por fim, o **sinal de Lenander** , embora raramente utilizado na prática, é descrito em livros e provas. Consiste em verificar uma diferença maior que 1°C entre a temperatura **axilar** e **retal** . A febre retal mais elevada sugeriria processo inflamatório pélvico.

Dica de prova: Os sinais mais frequentemente cobrados em questões de residência são **Blumberg** e **Rovsing** . Memorize bem suas definições e não os confunda com outros sinais.

Escore de Alvarado: Ferramenta de Estratificação de Risco

Quando há dúvida diagnóstica, especialmente em contextos onde o acesso rápido a exames de imagem é limitado, utilizamos o **Escore de Alvarado** . Este escore foi

desenvolvido para auxiliar na probabilidade pré-teste de apendicite aguda, sendo particularmente útil em unidades de pronto atendimento e atenção primária.

O escore é composto por critérios clínicos e laboratoriais, cada um valendo pontos específicos. Vamos detalhar cada componente: **Migração da dor** para fossa ilíaca direita vale 1 ponto; **Anorexia** vale 1 ponto; **Náuseas e/ou vômitos** valem 1 ponto; **Dor à palpação profunda em fossa ilíaca direita** vale 2 pontos - note que este item tem peso dobrado por ser mais específico; **Descompressão dolorosa** (sinal de Blumberg) vale 1 ponto; **Temperatura elevada** acima de 37,5°C vale 1 ponto; **Leucocitose** vale 2 pontos; e **Desvio à esquerda** vale 1 ponto.

A interpretação do escore segue a seguinte lógica: **Pontuação de 0 a 4** indica **baixo risco** de apendicite aguda. Nesses casos, podemos considerar observação ambulatorial, com reavaliação em 24 horas para verificar se houve progressão dos sintomas ou aumento da pontuação.

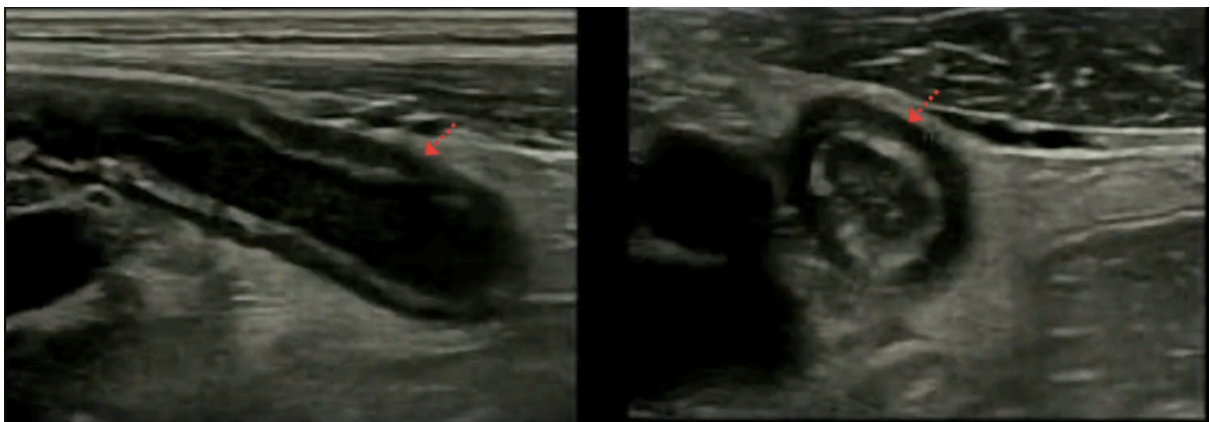
Pontuação de 5 a 6 indica **risco moderado**. O paciente não deve receber alta hospitalar. É necessária avaliação por cirurgião e solicitação de exames de imagem para confirmação diagnóstica antes de definir a conduta.

Pontuação igual ou superior a 7 indica **risco alto** de apendicite aguda. Nesses casos, devemos internar o paciente e acionar o cirurgião para avaliação. Em homens jovens (segunda ou terceira década de vida) com sintomas clássicos e escore alto, a probabilidade pré-teste de apendicite é superior a 90%, e em alguns protocolos é possível indicar cirurgia mesmo sem exame de imagem, pois a chance de diagnóstico diferencial é muito baixa nessa população específica.

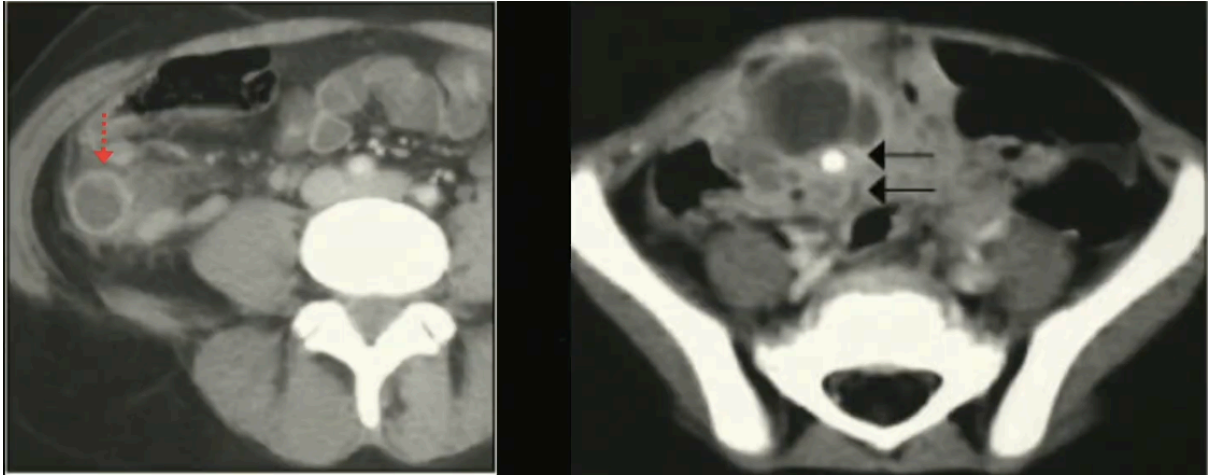
Exames Complementares: Diagnóstico por Imagem

Os **exames laboratoriais** na apendicite aguda tipicamente mostram **leucocitose** com desvio à esquerda e **proteína C reativa (PCR) elevada**. Entretanto, esses achados são inespecíficos e servem mais para corroborar a suspeita clínica do que para estabelecer o diagnóstico definitivo.

O exame de imagem de escolha depende do contexto clínico e da disponibilidade. O **ultrassom de abdome total** está indicado principalmente em **gestantes** (para evitar radiação ionizante), **pacientes magros** (onde a visualização do apêndice é tecnicamente mais fácil) sem acesso a tomografia, e **mulheres em idade fértil** (para avaliar diagnósticos diferenciais ginecológicos como torção de ovário ou doença inflamatória pélvica). O ultrassom também é preferível quando não há acesso imediato à tomografia computadorizada.



Porém, o exame **padrão-ouro** para diagnóstico de apendicite aguda é a **tomografia computadorizada de abdome e pelve COM CONTRASTE**. Este detalhe é crucial em provas discursivas - sempre especificar "com contraste", pois sem ele a visualização da parede intestinal fica prejudicada e o diagnóstico se torna muito menos acurado. A tomografia está indicada em **pacientes obesos**, quando há **dúvida diagnóstica persistente** apesar do escore de Alvarado e sempre que precisarmos de melhor caracterização do processo.



Os **achados tomográficos** característicos de apendicite incluem: apêndice com diâmetro aumentado (geralmente maior que 6-7mm), **não compressível**, com **espessamento de parede**, presença de **apendicolito** (fecalito calcificado dentro da luz apendicular), **borramento da gordura periapendicular** (sinal de inflamação local) e **mesoapêndice espessado**. Nos casos complicados, podemos identificar coleções líquidas (abscessos), líquido livre peritoneal e até pneumoperitônio quando há perfuração.

Em **gestantes** onde o ultrassom não foi esclarecedor e a suspeita clínica permanece alta, a **ressonância magnética** é o exame de escolha, pois não utiliza radiação ionizante e tem excelente acurácia diagnóstica. O mesmo se aplica quando a tomografia é inconclusiva e ainda há forte suspeita clínica.

Tratamento: Abordagem Cirúrgica

A conduta inicial em todo paciente com suspeita de apendicite aguda, independentemente da decisão cirúrgica, consiste em medidas de suporte: **hidratação venosa adequada**, **analgesia** (não há mais o conceito ultrapassado de que analgesia "mascara" o quadro) e **antibioticoterapia de amplo espectro** cobrindo bactérias gram-negativas e anaeróbios.

O tratamento definitivo da apendicite aguda não complicada é a **apendicectomia**, preferencialmente por **videolaparoscopia**. A abordagem laparoscópica se tornou o padrão-ouro porque oferece inúmeras vantagens: melhor visualização da cavidade abdominal (permitindo exploração completa e identificação de outros diagnósticos), menor dor pós-operatória, retorno mais rápido às atividades, melhor resultado estético, menor taxa de infecção de ferida operatória e menor incidência de aderências e hérnias incisionais a longo prazo.

A apendicectomia videolaparoscópica é considerada cirurgia de R1 em cirurgia geral - ou seja, é uma das primeiras cirurgias que o residente precisa dominar. Nos casos iniciais, sem complicações importantes, trata-se de procedimento tecnicamente simples e com baixíssima morbidade.

Quando a apendicectomia convencional (aberta) é necessária ou ainda realizada em alguns serviços, as **incisões** mais utilizadas são: **incisão de Davis** (transversa em fossa ilíaca direita) e **incisão de McBurney** (oblíqua seguindo a orientação das fibras do músculo oblíquo externo). Estas incisões respeitam os planos anatômicos e causam menos dano muscular.

Tratamento: Situações Especiais

Existem cenários específicos que merecem discussão à parte, pois a conduta pode diferir do padrão habitual.

A **apendicectomia de intervalo** é uma exceção à regra de sempre operar imediatamente. Está indicada em casos de **apendicite complicada com formação de plastrão** ou **abscesso** em fossa ilíaca direita, quando o paciente se apresenta relativamente estável hemodinamicamente. Nestes casos, o protocolo consiste em: realizar **drenagem percutânea guiada** do abscesso (se tecnicamente viável e se o abscesso não for muito pequeno), manter **antibioticoterapia intravenosa por 14 dias**, realizar **tomografia de controle** após esse período para documentar resolução do processo inflamatório, realizar **colonoscopia** em até três semanas (para afastar neoplasia colônica que pode ter causado obstrução e simulado apendicite) e, se a

colonoscopia não mostrar alterações significativas, programar **cirurgia eletiva de apendicectomia em 6 a 8 semanas**.

A racionalidade por trás dessa abordagem é que operar um paciente na fase aguda de um abscesso aumenta significativamente o risco cirúrgico, com maior chance de lesão de alças intestinais aderidas ao processo inflamatório e maior dificuldade técnica. Entretanto, se o paciente não está estável, apresenta sinais de sepse ou piora clínica apesar da drenagem e antibióticos, a cirurgia de urgência está indicada.

Em **gestantes**, a apendicite aguda representa a **emergência cirúrgica não obstétrica mais comum**. O quadro clínico varia conforme a idade gestacional, sendo o diagnóstico mais desafiador no terceiro trimestre devido ao deslocamento superior do ceco pelo útero gravídico. A leucocitose fisiológica da gestação pode confundir a interpretação laboratorial. O melhor exame de imagem é a **ressonância magnética**, evitando radiação ao feto. O tratamento de escolha continua sendo a apendicectomia, preferencialmente por **laparoscopia**, idealmente realizada no **segundo trimestre** quando o útero não está tão grande e o risco anestésico é menor. No terceiro trimestre, a videolaparoscopia pode ser tecnicamente muito difícil ou impossível devido ao tamanho do útero, necessitando abordagem aberta.

O **tratamento não operatório** com antibioticoterapia isolada vem ganhando espaço na literatura para casos muito selecionados: **apendicite inicial** (sintomas há menos de 24 horas), **alterações tomográficas leves** (apêndice levemente espessado, sem coleção, sem grande borramento de gordura), quando há **dúvida diagnóstica importante** (por exemplo, em mulheres onde diagnósticos ginecológicos são possíveis), em pacientes com **risco cirúrgico proibitivo** (cardiopatas graves, idosos muito frágeis) ou em **loais isolados** sem acesso a centro cirúrgico.

É fundamental informar o paciente que a taxa de **recidiva** da apendicite após tratamento conservador é considerável, podendo chegar a **30% no primeiro ano**. Portanto, esta não é uma conduta de primeira escolha, mas uma alternativa para situações específicas.

Achados Intraoperatórios: E Se Não For Apendicite?

Durante a exploração cirúrgica, podemos encontrar cenários diferentes do esperado. Se há apenas **inflamação leve do apêndice** sem outro diagnóstico claro, realizamos a **apendicectomia tática** - removemos o apêndice porque ele está inflamado e sua permanência pode levar a um episódio futuro de apendicite verdadeira.

Se identificamos **patologia ginecológica** como causa principal (por exemplo, torção de ovário, abscesso tubo-ovariano, doença inflamatória pélvica), devemos chamar a equipe de ginecologia. Se o apêndice estiver inflamado apenas por **contiguidade** (inflamação secundária ao processo adjacente), podemos considerar não removê-lo, mas esta é uma decisão individualizada.

Se não encontramos **nenhuma alteração** - abdome completamente normal - ainda assim realizamos a apendicectomia tática na maioria dos casos. Isso evita que o paciente desenvolva apendicite verdadeira no futuro e necessite nova cirurgia. Além disso, previne confusão diagnóstica futura, pois a ausência do apêndice afasta definitivamente este diagnóstico.

Se há **outro diagnóstico não infeccioso** claro (como hematoma de psoas, líquido livre por outra causa não infecciosa, divertículo de Meckel), tratamos a causa encontrada e avaliamos caso a caso a necessidade de remover o apêndice.

Diverticulite Aguda: Conceitos Fundamentais

Agora vamos abordar a segunda grande causa de abdome agudo inflamatório: a **diverticulite aguda**. É fundamental primeiro diferenciar três conceitos que frequentemente causam confusão: **divertículo** é a protrusão da mucosa e submucosa através da camada muscular da parede colônica, formando uma pequena bolsa. Quando falamos de **divertículos no cólon**, estamos na verdade nos referindo a **pseudodivertículos**, pois não envolvem todas as camadas da parede intestinal, diferentemente dos divertículos verdadeiros (como o divertículo de Meckel).

Doença diverticular dos cólons é a simples presença de divertículos, que pode ser assintomática ou causar sintomas leves e inespecíficos. Muitos pacientes descobrem ter divertículos incidentalmente durante colonoscopia ou tomografia realizadas por outros motivos.

Diverticulite aguda é a **complicação inflamatória e infecciosa** desses divertículos, geralmente causada por **microperfuração** ou **obstrução** da luz diverticular por fecalito.

Diverticulite Aguda: Fatores de Risco

A diverticulite está fortemente associada a fatores do estilo de vida ocidental. Uma **dieta pobre em fibras e rica em carne vermelha** aumenta o risco, pois fezes mais endurecidas e menor volume fecal elevam a pressão intraluminal do cólon, favorecendo a formação de divertículos e sua posterior inflamação. A **idade avançada** é um fator de risco importante, com incidência crescente após os 50 anos. O **tabagismo** está associado a maior risco de diverticulite e suas complicações. O **uso abusivo de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs)** pode precipitar episódios de diverticulite ao causar lesão mucosa. **Sedentarismo** e **obesidade** também aumentam o risco.

As duas principais complicações da doença diverticular são: **diverticulite aguda**, mais comum no **cólon esquerdo**, especialmente no **sigmoide** (devido à menor calibre do sigmoide e maior pressão intraluminal nesta região), e **sangramento diverticular**, que curiosamente é mais comum no **cólon direito**.

Pegadinha clínica importante: Em pacientes **idosos e orientais**, a diverticulite pode ocorrer no **cólon direito** (diverticulite cecal). Quando um paciente idoso ou de ascendência asiática apresenta dor em fossa ilíaca direita com febre e leucocitose, não pense apenas em apendicite - diverticulite cecal deve estar no diagnóstico diferencial. A diferenciação definitiva é feita pela tomografia.

Diverticulite Aguda: Quadro Clínico

O quadro clínico típico da diverticulite aguda inclui: **dor localizada em fossa ilíaca esquerda**, de caráter contínuo e progressivo; **febre**; **mal-estar geral**; alteração do hábito intestinal, que pode ser tanto **constipação** (mais comum) quanto diarreia; **náuseas**; e às vezes **sangramento evacuatório**, embora este seja mais característico do sangramento diverticular não complicado.

Ao exame físico encontramos **dor à palpação profunda** em fossa ilíaca esquerda e flanco esquerdo, podendo haver **sinais de irritação peritoneal** (Blumberg positivo em fossa ilíaca esquerda) quando há perfuração localizada ou peritonite.

Laboratorialmente observamos **leucocitose** e **PCR elevada**, semelhante à apendicite, mas esses achados são inespecíficos.

Diverticulite Aguda: Diagnóstico por Imagem

O exame padrão-ouro para diagnóstico de diverticulite aguda é a **tomografia computadorizada de abdome e pelve COM CONTRASTE ENDOVENOSO**. Novamente, em provas discursivas, é imprescindível especificar "com contraste", pois sem ele não conseguimos avaliar adequadamente a parede intestinal e o grau de inflamação.

Os **achados tomográficos** característicos incluem: **espessamento da parede do cólon** (geralmente sigmoide), **borramento da gordura mesentérica** adjacente ao segmento acometido, **presença de divertículos** visíveis como pequenas protrusões saculares na parede colônica, presença de **abscessos** (coleções líquidas com realce periférico) ou **líquido livre** na pelve, e nos casos de perfuração podemos identificar pequenos focos de **pneumoperitônio** localizados ou até pneumoperitônio difuso.

Um ponto crucial sobre o uso da **colonoscopia** na diverticulite: ela está **CONTRAINDICADA** durante o surto agudo. A insuflação de ar necessária para realizar o exame pode causar perfuração em uma parede intestinal já comprometida

pela inflamação. A colonoscopia deve ser realizada **eletivamente**, cerca de **3 a 4 semanas após a resolução do quadro agudo**, com o objetivo principal de **excluir neoplasia colônica**, que pode se apresentar de forma similar à diverticulite ou estar associada a ela.

Classificação de Hinchey: Essencial Para o Tratamento

A **classificação de Hinchey** para diverticulite aguda é absolutamente fundamental. É impossível falar de diverticulite em prova de residência sem abordar esta classificação, pois ela guia diretamente a conduta terapêutica. Vamos detalhar cada estágio:

Hinchey 0 ou 1A - Diverticulite Não Complicada: O paciente apresenta apenas espessamento de parede colônica e borramento da gordura mesentérica, sem formação de abscesso ou coleção líquida. Nestes casos, a conduta é **conservadora**: antibioticoterapia intravenosa ou até oral (dependendo da gravidade), analgesia, hidratação e dieta. Se o paciente evolui bem, pode receber alta com antibiótico oral para completar 7 a 10 dias de tratamento.

Hinchey 1B - Abscesso Pericólico Pequeno: Presença de abscesso **menor que 5 cm**, localizado **próximo ao segmento acometido**. A conduta ainda pode ser conservadora com antibioticoterapia, mas devemos considerar **drenagem percutânea guiada por tomografia ou ultrassom** se o abscesso for facilmente acessível. A drenagem acelera a resolução do quadro e reduz o risco de necessidade de cirurgia de urgência.

Hinchey 2 - Abscesso Distante ou Maior: Presença de abscesso **maior que 5 cm** ou abscesso em **localização distante** do segmento acometido (por exemplo, abscesso pélvico em caso de diverticulite sigmoideana). Nestes casos, a **drenagem percutânea** está formalmente indicada, associada à antibioticoterapia. Se não for possível realizar drenagem percutânea (abscesso em local de difícil acesso, múltiplos abscessos septados) ou se houver **falha do tratamento conservador** após 48-72 horas, está indicada **cirurgia de urgência**.

Hinchey 3 - Peritonite Purulenta: Há perfuração do cólon com extravasamento de conteúdo purulento para a cavidade peritoneal, causando peritonite difusa. O paciente apresenta sinais de **irritação peritoneal em todo o abdome**, com defesa muscular, dor à descompressão, distensão e sinais de sepse. Este é um quadro de **urgência cirúrgica absoluta**. Não há papel para tratamento conservador isolado.

Hinchey 4 - Peritonite Fecal: É o estágio mais grave, com **perfuração colônica franca** e extravasamento de **conteúdo fecal** para a cavidade abdominal. O paciente está gravemente enfermo, frequentemente em choque séptico. É **urgência cirúrgica extrema**, com altíssima morbimortalidade.

Oclusão Intestinal ou Fístula: Embora não façam parte dos critérios de Hinchey propriamente ditos, são complicações da diverticulite que também requerem tratamento cirúrgico, geralmente de forma eletiva após controle da fase aguda.

Tratamento Cirúrgico: Cirurgia de Hartmann

Quando indicamos cirurgia na diverticulite aguda complicada (Hinchey 3 ou 4, ou Hinchey 2 com falha do tratamento conservador), o procedimento de escolha na maioria dos casos é a **cirurgia de Hartmann**. Este procedimento consiste em: realizar laparotomia exploradora, **ressecar o segmento intestinal** acometido (geralmente sigmoide), **exteriorizar** o coto proximal como **colostomia terminal** (geralmente trazendo o cólon descendente através da parede abdominal em fossa ilíaca esquerda) e fechar o **coto retal** distal, deixando-o na pelve (formando um "coto de Hartmann").

Esta cirurgia evita fazer uma anastomose intestinal em condições desfavoráveis (infecção, edema, contaminação fecal, paciente instável), o que teria alto risco de deiscência. O trânsito intestinal pode ser **reconstruído posteriormente**, em um segundo tempo cirúrgico eletivo (geralmente após 3 a 6 meses), quando o processo inflamatório está completamente resolvido, o paciente está nutrido e preparado, e as condições técnicas são ótimas.

Em casos selecionados de **Hinchey 1B ou 2** com achados cirúrgicos favoráveis (perfuração pequena, mínima contaminação, paciente estável), podemos considerar **anastomose primária** no mesmo tempo cirúrgico, ressecando o segmento e reconectando imediatamente. Entretanto, esta decisão requer experiência do cirurgião e condições ideais.

Complicações da Diverticulite: Fístulas

A complicação mais **famosa** em provas de residência, embora não seja a mais comum, é a **fístula**. A complicação mais **comum** é na verdade a **estenose** (estreitamento) do cólon por fibrose secundária a episódios repetidos de diverticulite.

A fístula mais característica é a **fístula colovesical** (do cólon para a bexiga urinária). Esta fístula ocorre porque o sigmoide inflamado está em íntimo contato com a cúpula vesical, e a inflamação crônica pode perfurar através da parede vesical, criando um trajeto fistuloso entre as duas estruturas.

Os sintomas clássicos da fístula colovesical são: **pneumatúria** (eliminação de ar pela urina, geralmente descrita pelo paciente como "bolhas no xixi") e **fecalúria** (presença de material fecalóide na urina, que pode ser vista macroscopicamente ou detectada pela presença de coliformes fecais na urocultura). O paciente frequentemente apresenta **infecções urinárias de repetição** por bactérias entéricas.

Na tomografia podemos identificar **ar intravesical** (pneumocistia) em um paciente que não foi submetido a instrumentação vesical recente, o que é altamente sugestivo de fístula. Em casos duvidosos, podemos realizar **cistoscopia** (que pode mostrar a abertura fistulosa na parede vesical) ou **enema opaco** (que pode demonstrar passagem de contraste para a bexiga).

O **tratamento das fístulas** geralmente não é realizado na urgência. Durante a fase aguda, tratamos a infecção com antibióticos e suporte clínico. O tratamento definitivo é cirúrgico e deve ser **programado eletivamente** após controle completo

do processo inflamatório (geralmente de 2 a 3 meses), quando as condições técnicas são muito melhores. A cirurgia consiste em ressecção do segmento colônico com a fístula e reparo da parede vesical.

Indicações de Cirurgia Eletiva na Diverticulite

Após um episódio agudo de diverticulite, quando devemos indicar cirurgia eletiva preventiva? As principais indicações são: **dois ou mais episódios documentados** de diverticulite aguda (o risco de novos episódios e complicações aumenta progressivamente); pacientes **imunocomprometidos** (diabéticos, usuários de corticoides, transplantados, HIV positivos) que têm maior risco de complicações graves; pacientes **jovens** (menor que 50 anos) - aqui há controvérsia, pois antes se operava de rotina após o primeiro episódio, mas hoje a tendência é individualizar, estimular mudanças de hábitos de vida (aumento de fibras na dieta, exercícios físicos, cessação do tabagismo) e operar apenas se houver recorrência; **sintomas crônicos persistentes**, pois o paciente pode desenvolver estenose sintomática com obstipação progressiva; e após **qualquer episódio complicado** (Hinchey 2, 3 ou 4) que foi tratado inicialmente de forma conservadora, principalmente se houve necessidade de drenagem percutânea.

A cirurgia eletiva consiste em **sigmoidectomia** (ou colectomia segmentar do segmento acometido) com **anastomose primária**, geralmente realizada por **videolaparoscopia**, com excelentes resultados e baixa morbidade, muito diferente da cirurgia de urgência.

Gatilhos Diagnósticos e Resumo Final

Para encerrar, vamos consolidar os **gatilhos** mais importantes para reconhecer estas duas patologias em questões de prova:

Apendicite Aguda:

- Diagnóstico fundamentalmente **clínico**

- **Escore de Alvarado** para estratificação quando há dúvida (maior ou igual a 7 = risco alto)
- Sinais clínicos mais cobrados: **Blumberg e Rovsing**
- Tratamento: **Apendicectomia** (preferencialmente videolaparoscópica)
- Tratamento não cirúrgico é **exceção**, não a regra
- Em gestantes: exame de escolha é **ressonância magnética**

Diverticulite Aguda:

- Dor em **fossa ilíaca esquerda** (sigmoide é o local mais comum)
- Diagnóstico por **tomografia de abdome e pelve com contraste**
- **Classificação de Hinchey** define a conduta
- Hinchey 0/1A e 1B/2: conduta primariamente **clínica**, considerar drenagem em 1B e 2
- Hinchey 3 e 4: **cirurgia de urgência** (Hartmann é o procedimento mais seguro)
- Complicação mais famosa: **fístula colovesical** (pneumatúria + fecalúria)
- **Colonoscopia contraindicada** no surto agudo por risco de perfuração